

Paciente	Cecilia Maria Albergaria Silva	Atendimento	1.300.781
Nome Social		Convênio	Casu / Enfermaria
Data Nascto	30/06/2020 3 meses	Registro	01/10/2020 13:21:02
Data Entrada	04/08/2020 11:40:09	Prontuário	301.935
Setor/Leito	3º Andar - Internação Materno Infantil - 321		
Médico Resp	Silvania Ferreira Kohnert		

ALTA HOSPITALAR - PEDIATRIA

Internado em: 04/08/2020 Tempo de internação: 58

Data da Alta: 01/10/2020



DIAGNÓSTICO DA INTERNAÇÃO: P52 Hemorragia intracran nao-traum feto rec-nasc

DIAGNÓSTICO DE ALTA: P52 Hemorragia intracran nao-traum feto rec-nasc

Data de admissão enfermarias pediátrica: 29/09/2020
01/10/2020

Data da alta enfermarias pediátrica:

Procedência: CTI pediátrico do Hospital Belo Horizonte

Destino: Domicílio

À alta: Dias de internação: 58 dias Peso: 3805g

Data de admissão CTI pediátrico: 04/08/2020

Data da alta CTI pediátrico: 29/09/2020

Procedência: Pronto atendimento do Hospital Belo Horizonte

Destino: Pediatria do Hospital Belo Horizonte

À alta: Dias de internação: 57 dias

Peso: 3882g Perímetro cefálico: 37,5 cm. Comprimento: 51cm

HISTÓRIA:

Lactente admitida com 1 mês e 5 dias, apresentando crise convulsiva tônica clônica, com duração superior a 15 minutos, associada a hipotermia. Até aquele momento, em aleitamento exclusivo, com adequado ganho ponderal. A família cumpria o isolamento social.

No pronto atendimento, verificado abaulamento de fontanela, feito dois bolus de midazolam, colocado em oxigênio, glicemia capilar: 166 mg/dl. Recebeu uma dose de ceftriaxona e coletado rastreio infeccioso, ions e gasometria. Mãe nega herpes na gestação e após.

Encaminhada para monitorização acompanhada de médico.

EVOLUÇÃO EM CTI

NEUROLÓGICO:

Admitido com quadro neurológico agudo (convulsão e abaulamento de fontanela).

Ultrassonografia transfontanelar (04/08): hemorragia intraventricular grau II-III bilateral.

Tomografia de encéfalo (04/08): extensa hemorragia em caudado à direita com inundação ventricular e hidrocefalia.

Implantada derrivação ventricular externa (DVE), em 04/08.

Angiotomografia arterial e venosa intracraniana (11/08): Sem má formação arterio venosa (laudo em anexo).

A crinaça não tolerou a retirada da derivação ventricular, sendo submetida à implantação de derivação ventriculo peritoneal, em 08/09/20.

Ressonância de encéfalo (16/08): hidrocefalia, resquícios de sangramento e áreas de malácea em região periventricular posterior bilateral, frontal esquerda.

Controladas crises convulsivas com fenobarbital. A criança apresenta melhora progressiva do quadro neurológico, sendo a reduzida aceitação oral a alteração mais importante.

RESPIRATÓRIO

Entubada, à admissão, em função do quadro neurológico (irritabilidade e hipertonia). Como medida de proteção cerebral, foi mantida em ventilação, com parâmetros baixos, até o dia 12/08. Manteve bom padrão respiratório, ar ambiente, sendo reintubada, eletivamente, para procedimento neurocirurgico.

CARDIOVASCULAR/HEMATOLÓGICO:

Admitida com hemoglobina de 5,6, apresnetando instabilidade hemodinâmica. Recebeu hemotransfusão e

Dr. Rafael Lima Alves Simões
MÉDICO
CON REG 76413
CON REG 25524

Paciente	Cecilia Maria Albergaria Silva	Atendimento	1.300.781
Nome Social		Convênio	Casu / Enfermaria
Data Nascto	30/06/2020 3 meses	Registro	01/10/2020 13:21:02
Data Entrada	04/08/2020 11:40:09	Prontuário	301.935
Setor/Leito	3º Andar - Internação Materno Infantil - 321		
Médico Resp	Silvania Ferreira Kohnert		

necessitou de adrenalina, em dose baixa, por 24h.

Para investigação da causa da hemorragia cerebral, foi solicitada avaliação da hematologia que indicou dosagem do fator XIII. O resultado sofre alteração pelo uso do DDVP e foi repetida coleta, em 28/09 (em andamento). Apresenta, atualmente, anemia multifatorial, sem repercussão hemodinâmica e está sendo mantida reposição enteral de ferro.

INFECCIOSO: Iniciados à admissão, ceftriaxona, ampicilina e aciclovir. Com diagnóstico de sangramento cerebral, os antibióticos foram suspensos em 05/08.

Em 10/08, iniciou com febre. Iniciado tratamento para infecção urinária, mas pela possibilidade de infecção em sistema nervoso central, a amicacina foi substituída por cefotaxima.

Urocultura(14/08/20) : Citrobacter. freundii.

Pela persistente alteração líquórica, optado por estender tratamento para ventriculite. Foi observada melhora gradual do exame, mas as culturas não mostraram crescimento.

Completo 21 dias de vancomicina e cefepime.

NUTRICIONAL:

Iniciada dieta no 2º dia de internação. Apresentou vômitos repetidos, atribuídos ao quadro neurológico. Necessitou de bomba de infusão, em sonda entérica.

Em 10/09, iniciada a oferta de aleitamento materno e observada piora do padrão de sucção, com exacerbado reflexo de vômito. Foi mantido acompanhamento com a fonoaudiologia. O padrão de sucção é irregular, em termos de aceitação, mas sem evidências de disfagia. A sucção é melhor ao seio materno. Com a observação de choro, durante em alguns horários de sucção, em 10/09, foi iniciado omeprazol. Pela curva estacionada de peso, a sonda gástrica foi mantida até a manhã de hoje, com a programação de transferência para pediatria com a mãe, para aleitamento.

Peso de admissão: 3200g. Peso de alta: 3882g

METABOLICO:

Evoluiu com *Diabetes Insipidus*, recebeu DDAVP de 05/08 até 18/09.

Por cursar também com hiponatremia, foi feita investigação de eixo hipofisário, que não mostrou alterações (exames em anexo).

ACESSO VENOSO: Epicutâneo membro superior direito: 33 dias
Epicutâneo cefálico esquerdo : 12dias

ÚLTIMOS EXAMES:

13/09/20	Hb: 8,8	HT: 28	Hm: 3,17	Plaq:290.000	
	Gl: 5200	B: 0 S: 16 M:6	E: 3 L: 73		
28/09/20	Na: 133	K: 4,6	Cl: 103		
	Fator XIII: em andamento.				

EVOLUÇÃO EM ENFERMARIA PEDIÁTRICA:

Criança permaneceu em enfermaria por 48 horas, acompanhado evolução e aceitação de aleitamento materno e fórmula infantil, com boa progressão e ganho de peso. Avaliada pela fonoaudióloga que liberou para atendimento domiciliar. Recebe alta em boas condições clínicas, sem queixas, com orientação de manter acompanhamentos com especialistas.

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

Hemorragia intraventricular espontânea (sem etiologia definida - AngioTC sem mal formação arterio-venosa)

Anemia aguda (hemotransfundida)

Crise convulsiva controlada

Distúrbio de sódio - *Diabetes insipidus t e Síndrome perdedora de sal ransitórios*

Refluxo gastro-esofágico presumido

Resultado de dosagem de fator XIII 152% (VR 70-140%)

Ventriculite tratada- diagnóstico por alteração líquórica - culturas negativas.

PROPOSTAS:

Acompanhar aceitação da dieta e curva ponderal com pediatra que acompanha.

Dr. Rafael Luiz Alves Santos
MÉDICO
C.H. 76413
CON. FOL. 76413

Paciente	Cecilia Maria Albergaria Silva	Atendimento	1.300.781
Nome Social		Convênio	Casu / Enfermaria
Data Nascto	30/06/2020 3 meses	Registro	01/10/2020 13:21:02
Data Entrada	04/08/2020 11:40:09	Prontuário	301.935
Setor/Leito	3º Andar - Internação Materno Infantil - 321		
Médico Resp	Silvania Ferreira Kohnert		

Agendar consulta com pediatra ate 72horas apos alta hospitalar.
Acompanhamento ambulatorial de: neurologia pediátrica, endocrinologia pediátrica e neurocirurgia.
Acompanhamento com fisioterapia
Acompanhamento com fonoaudiologia
Cobrar, no laboratório, dosagem de Fator XIII (após o resultado, avaliação da hematologia)

CD: Alta hospitalar.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2020

Dra. Raquel Luisa Alves Simoes (CRM 76413) CRM 76413



Dra. Raquel Luisa Alves Simoes
CRM 76413
MÉDICA
CON ROL 2017/2018